



التمريض

إعداد د/انيسه المبني
وتنسيق المدرب/جلال الكريزي



ORSupply.com

تنسيق د/جلال الكريزي

العناية التمريضية الكاملة

♣ - تعريف التمريض :-

هو العناية الكاملة التي تقدم للمرضي لمساعدتهم علي اكتساب أقصى درجات الصحة وذلك بمراعاة حالته النفسية والاجتماعية والعقلية والباطنية

♣ - الأسس هي العلم والفن والروح

- علم ويعني : الاعتماد علي المعلومات في العلوم
- الحيوية مثل علم التشريح وعلم وظائف الأعضاء
- فن : وهو تنمية المهارة الفنية في جميع مختلف طرق العناية التمريضية

- روح : وهو معاملة المرضى وكأنهم أقربائك نعطيهم كل الاهتمام امتثالاً لقول الرسول الكريم صلي الله عليه وسلم (لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحبه

لنفسه) قال تعالى : وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى

- المرضى :
- ١ واجباته نحو المريض
- ١- تثقيفه حول حالته وطرق الوقاية
- ٢- توصيل شكواه بكل صدق وأمانة ألي الطبيب
- ٣- تظمينه و توفير له الهدوء ومتابعة حالته وذلك من خلال الأعراض والعلامات أثناء استخدامه للدواء

- واجباته نحو الطبيب :
- ١- تنفيذ إعطاء الدواء في ميعاده وبالطريقة المطلوبة
- ٢- مساعدة الطبيب في التشخيص وتحديد حالة المريض
- ٣- إذا حصل أي خطأ أو معلومات اكتشفها يبلغها للطبيب فوراً
- ٤- تنفيذ ما طلبه الطبيب دون أي تأخير مثل نقل دم أو فحوصات ضرورية
- ٥- الاحتفاظ بملف المريض بمحتوياته وعدم الإهمال به و خلطها بملفات أخوي كما هو مرجع للدراسات المستقبلية ووضع عليه أسمه وسم المريض لكي يعرف كل طبيب المرضى حقهم أثناء المرور علي المرضى في الصباح
- ٦- تبليغ الطبيب بما سوف تقدمه من إسعاف أولي لأنفاذ حيات المصاب في الحالات التي تستدعي إعطائها قبل وصول الطبيب مثل التشنج المفاجئ

- (٣) واجباته نحو أهل المريض :
- ١ -- تطمينهم علي حالة المريض وتطورات صحته
- ٢ -- تقديم الإرشادات الصحية التي تساعدهم علي العناية بالمريض بالمنزل
- ٣ -- تثقيفهم حول مرضه والوقاية منه

♣ - طريقة استقبال المريض :-

- ١ - بترحيب وود صادق ووجه بش
- ٢ - ازالة مخاوفه ورهبته من المشفى فهو قد يخاف من (العلاج - النوم في مكان غير مألوف له)
- ٣ - تجهيز السرير ويكون نضيف ومرتب
- ٤ -- مساعدة المريض بارتداء ملابس المشفى
- ٣ - شرح للمرافق بنظام المشفى ومواعيد الزيارة والطعام

الاسس العامة التي تتبع عند دخول أي مريض المستشفى :-

- ١ -- توفير وسيلة مريحة لنقل المريض من الاستقبال الي القسم
- ٢ -- الحصول علي معلومات خاصة من المريض وتدوينها بالسجل الخاص
- ٣ -- حفظ امتعت المريض الشخصية لحين خروجه
- ٤ -- تحضير واعداد المريض للفحص الطبي
- ٥ -- اعطاء المريض ملابس المشفى
- ٦ -- تجهيز للتحاليل الطبية التي تساعد في التشخيص
- ٧ -- شرح نظام المشفى وطرق العلاج

تنسيق د/جلال الكريزي

♣-- طرق نقل المريض الي القسم :-

١-- عن العيادات الخارجية او قسم الاستقبال بواسطة كرسي متحرك او نقالة

٢-- بمساعدة اهل المريض في حين يكون غير قادر علي المشي

العلامات الحيوية -- Veatal seanse

الحرارة - Temperature

هي درجة الحرارة التي يحتفظ بها الجسم وهي درجة التوازن بين الحرارة المفقودة والحرارة المكتسبة

درجة الحرارة الطبيعية هي (٣٦ - ٣٧)



ADAM

من فتحت الشرج (الدبر) - المنطقة الاربية
طريقة اخذ الحرارة تجري تطبيق مهاري في العملي

عوامل ارتفاع درجة الحرارة :-

١- التمارين الرياضية ٢- بعض الامراض

٣- نوعية الطعام ٤-- الانفعالات

٥-- زيادة حرارة الجو ٦--- الجنس

عوامل انخفاض الحرارة :-

١- الصوم ٢- النوم ٣- الركود الذهني

مواضع اخذ الحرارة :-

الموضع	التغير	الحالات التالية
الفم	تسجل كما هي	البالغين - الواعين
تحت الابط	تسجل كما هي	كسر الفك - حروق الوجه - الاطفال - الحالات النفسية
فتحة الشرج	تخفض 1/2 درجة قبل التسجيل	الاطفال - فاقدين الوعي
المنطقة الاربية	نزيد 1/2 درجة قبل التسجيل	حين تتعذر الاماكن السابقة

النبض :- PULS

♥-التعريف :- عبارة عن تمدد شرياني ناتج عن ازدياد حجم الدم المتدفق في الشرايين بواسطة انقباض عضلة البطين الايسر للقلب كل دقة من دقات القلب والجهة العليا فترة العمل والمنخفضة فترة الراحة

♥-الهدف من اخذ النبض :

١-- لمعرفة حالة القلب والاوعية الدموية

٢-- لتشخيص حالة القلب والاوعية الدموية

♥- اماكن اخذ النبض : (الشريان الكعبري - الشريان الساعدي - الشريان السباتي - من القلب مباشرة - من الشريان الصدغي - الكاحل)

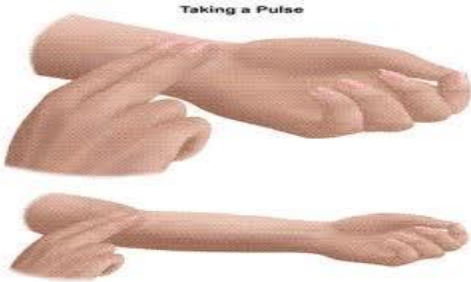
♥- النبض الطبيعي :-

١-البالغ :- من (٧٠ - ٨٠) دقة بالدقيقة الواحدة

٢-- الطفل حديث الولادة :- من (١٣٠ - ١٤٠) = =

٣-- اثناء السنوات الاولى من العمر (١١٠ - ١٢٠) =

٤-- كبار السن (٦٠ - ٧٠) = = =



تنسيق د/جلال الكريزي



بعض امكان اخذ النبض

♥- العوامل التي تؤثر في اختلاف النبض :-

- ١- السن ٢- الجنس ٣- الحجم ٤- الرياضة
- ٥- نوعية الطعام ٦- الوضعية ٧- ارتفاع درجة الحرارة
- ٨- بعض الادوية ٩- بعض الامراض

♥- الخواص العامة للنبض :-

- ١- انتظامه : يكون دائما منتظم الدقات وبقوة متكاملة لفترة زمنية متساوية
- ٢- حجمه : حجم كمية الدم المتدفق في الاوعية الدموية دائما ثابتة عندما يكون طبيعيا
- ٣- قوته : عادة يكون قوي وبمرور السن تقل قوته وتقاس قوة النبض بانها عالية او منخفضة

♥- الضغط :- Plood Brtuer

الخواص العامة :- الجهاز الدوري عبارة عن جهاز مغلق تتحكم فيه خمسة عوامل هي :-

- ١-- عمل القلب كمضخة
- ٢-- المقاومة الخارجية اذ كان قطر الوعاء الشرياني قوي
- ٣-- كمية الدم مثل بعد النزيف يحدث هبوط
- ٤-- لزوجة الدم وهو كثرة البروتين فيحدث ارتفاع الدم
- ٥-- مرونة جدار الاوعية فاذا كانت قليلة المرونة يحدث فيها سيولة الدم فيؤدي الي النزيف فيؤثر في انخفاض الضغط عكس حالات تصلبها يحدث ارتفاع

♥- الضغط الانقباضي العالي :-

تظهر فيه النهاية العظمي علي جدران الشرايين نتيجة دفع البطين الايسر للقلب الدم في الشريان الاورطي وهو يبلغ حوالي من (١٠٠ - ١١٠ - ١٢٠)

♥- الضغط الانبساطي: وهو الحد الأدنى الطبيعي ويبلغ (٦٠ - ٧٠ - ٨٠)

♥- العوامل التي تزيد في ارتفاع الضغط :

- ١-- الانفعالات ٢--زيادة الملح في الطعام ٣- السمنة المفرطة
- ٤-- المشاكل ٥ - المفاجئات المخيفة بعض الامراض (القلب- الكلي - تسمم الحمل ... الخ)

♥-- التنفس Reaspreeture :-

♥- التعريف : هو عبارة عن شهيق وزفير ناتج عن دخول الاكسجين وخروج ثاني اكسيد الكربون من الرئة ويلاحظ من حركات الصدر الارتفاع والانخفاض

♥- العوامل التي تسبب تغيير في التنفس هي :-

- ١-- السن ٢--النوع ٣- التمارين الرياضية ٤--الانفعالات
- ٥---- بعض الادوية ٦- بعض الامراض ٧- الالم الحاد
- ٨-- ارتفاع درجة الحرارة ٩ -- الصدمة



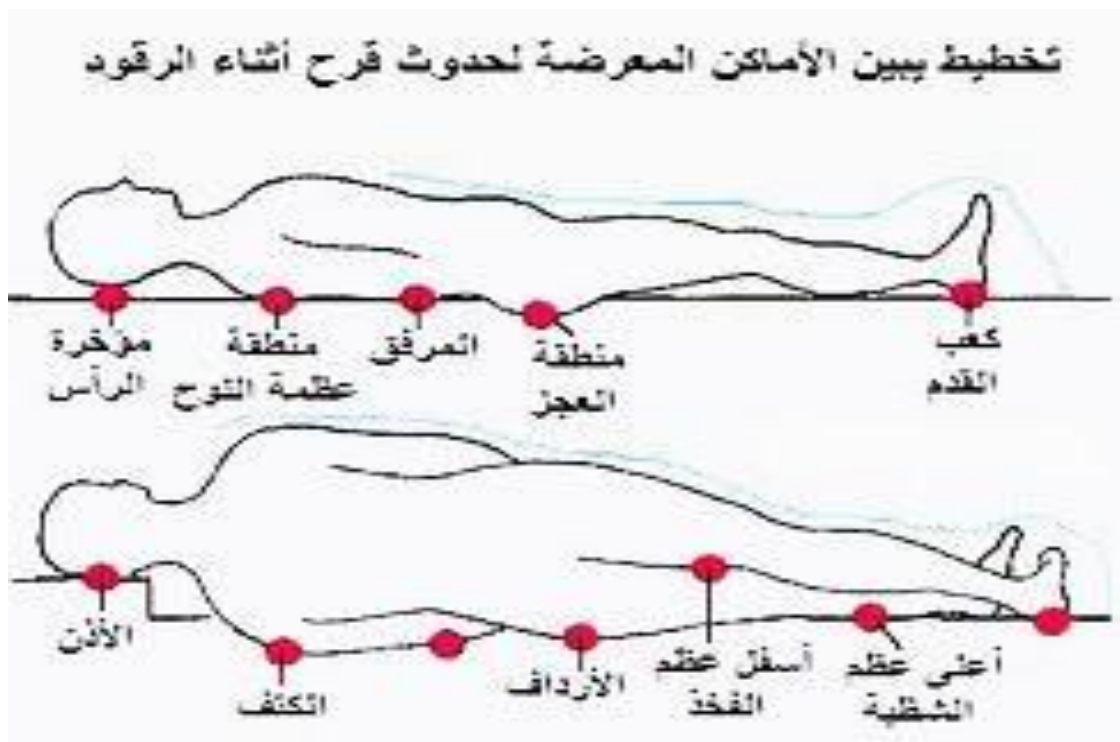
قروح الفراش

هي عباره عن جروح تحدث للشخص الملازم للفراش ون التحريك
الا احدى الجوانب وعدم تغيير الفراش

■ قروح الفراش :

■ الاسباب

- ١- بقاء المريض فترة في السرير دون تقلبيه
- ٢- عدم تغيير الفراش
- ٣- اهمال نظافة المريض
- ٤- بقاء المريض علي اماكن الارتكاز فترة طويلة



■ اعراض قروح الفراش : تنقسم الي :

١- الدرجة الاولى :

١- احمرار بسيط ٢- تنمل ٣- سخونة موضعية

■ المعالجة :

- ١ — تقليب المريض من وقت الي اخر
- ٢ -- تدليك مواقع الارتكاز بالفازلين او البودرة
- مواقع الارتكاز

٢- الدرجة الثانية :

- ١- تسليخ الجلد ٢- وجود دم بسيط ٣- الم بسيط
- ٤- سخونة موضعية ٥- عدم الشعور بالارتياح

■ المعالجة

- ١ -- تغير وضع نوم المريض الي احد الجوانب
- ٢ -- اعطاء المهدئات وخافضات الحرارة
- ٣ -- تطهير المنطقة ووضع احد المضادات الحيوية ويكون مرهم علي الجرح
- ٤ -- وضع شاش معقم علي الجرح اثناء النوم

٣- الدرجة الثالثة

- ١- ظهور الانسجة وبروز العظم لدرجة رؤيته
 - ٢- ظهور رائحة كريهة
 - ٣- ظهور ديدان بيضاء وقيح
 - ٤- ألم شديد وارتفاع درجة الحرارة
 - ٥- فقدان الشهية
 - ٦- الشعور بالإحباط وتغير مزاج المريض وتدهور حالته
- المعالجة :

- ١- المجارحة ولتكن ثلاث مرات باليوم بمطهر الهيدروجين
- ٢- تدبيل الشاش
- ٣- تغيير الملاية مع كل مجارحة
- ٤- اعطائه احد المضادات الحيوية حقن بالوريد
- ٥- مهدئات وخافضات الحرارة وصرف الفيتامينات ولتكن
فيتامين سي وفيفول
- ٦- التركيز علي التغذية



طرق إعطاء الدواء

يتم اعطاء الادوية عن طريق :- Medicine

١ -الحقن Injection ويتم عن طريق :

١-العضل ٢-الوريد ٣- تحت الجلد

٤- في الجلد نفس ٥- في المفصل ٦- في النخاع الشوكي

٧- في الشريان ٨- في القلب

٩- عن طريق الشرج:

١ بواسطة الحقنة الشرجية

٢ —تحاميل

٣ —موضعي : يوضع علي الجلد :

١ -- المراهم ٢ -- الكريمات -- الغسول

٤ -- عن طريق الاعضاء التناسلية : مثل التحاميل المهبلية

٥ عن طريق الفم : مثل

١ -- الشراب ٢ - الكبسولة ٣ -- الاقراص وتقسم الي :

١ -- بلع ٢ -- تحت اللسان ٣ - ومنها مضمضة ٤ - ومنها غرغرة

طريقة الحقن بالعضل I.M Intra muscular

التعريف : هو عبارة عن حقن دواء سائل في أنسجة العضلات

الهدف

- ١- عندما يسبب الدواء تهيج في الجلد - تحت الجلد او الوريد
- ٢- عندما يكون الامتصاص اسرع داخل الدم او تحت الجلد
- مواقع الاعطاء ١- اعلي الالية في المربع الأعلى الوحشي
- ٢- اعلي الفخذ من الامام ٣- اعلي الذراع

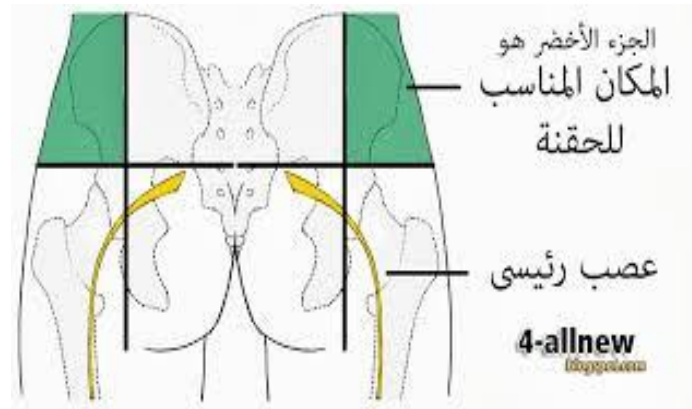
الاحتياطات الواجب مراعاتها :

- ١- وضع المريض بالوضعية المريحة
- ٢- تحديد موقع الحقن بطريقة صحيحة
- ٣- يكون الحقن عموديا بزاوية ٩٠
- ٤- التأكد من عدم وجود الدم عند سحب الدواء
- ٥- لا يعطي بالعضل اكثر من ٥ سي سي من كمية الدواء
- ٧- في حالة وجود ألم او احمرار - سخونة وذمة مكان الحقن
نعمل كمادات ساخنة وفي حالة ظهور بقع زرقاء نعمل
كمادات مع السبرت او ماء بارد



عضل بالكشف

عضل بالاليتين

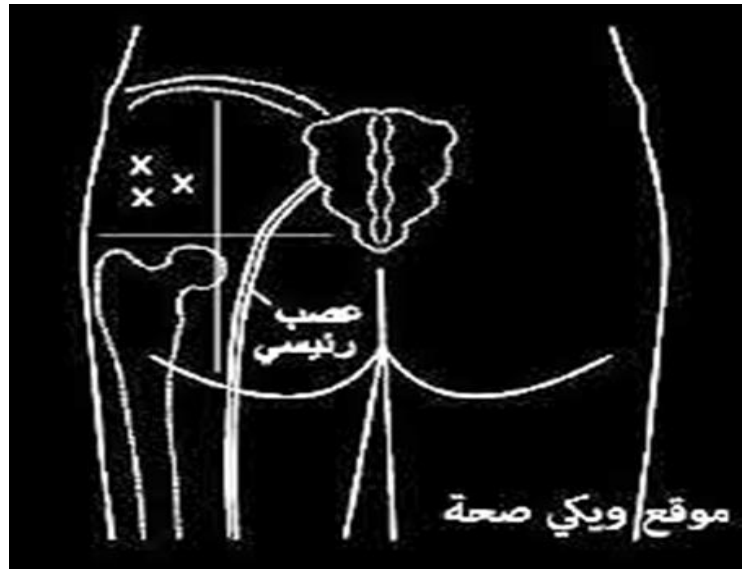
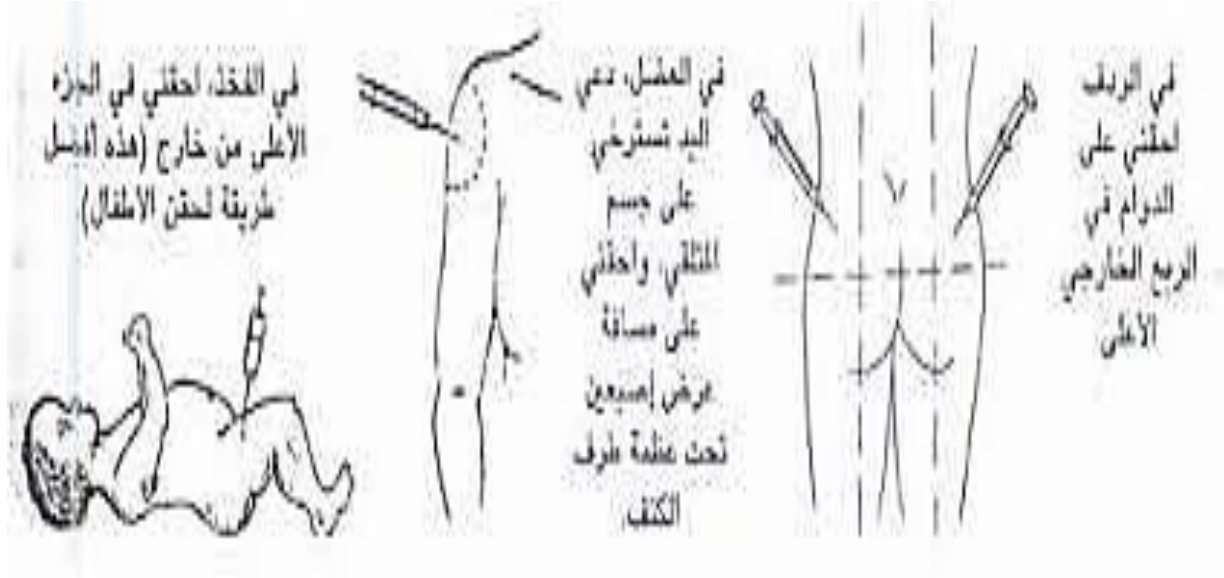


الجزء الأخضر هو
المكان المناسب
للحقنة

عصب رئيسي

4-allnew
pharmaceuticals

طريقه الضرب الصحيح للعضل



الحقن بالوريد

الحقن بالوريد I.V Intra venous
التعريف : هو عبارة عن حقن سائل داخل الوريد

الهدف :

- ١- اعطاء مفعول اسرع
- ٢- التشخيص بالصبغات
- ٣-- اعطاء كمية كبيرة من الدواء كالمحاليل ونقل الدم
- ٤-- عندما يعمل الدواء تهيج اذا اعطي بطرق اخري
- ٥-- عندما لا تستطيع اعطائه عن طريق الفم في حالة نقل الدم

موقع الاعطاء :

- ١- داخل ا ي وريد في الجسم

الاحتياطات اللازمة :

- ١- تحديد الوريد المناسب والواضح
- ٢-- يكون حجم النيدل مناسباً لحجم الوريد
- ٣-- يعطي الدواء ببطيء شديد
- ٤-- ملاحظة علامة التسرب للسوائل خارج الوريد هي المبرودة شحوب فيجب ايقاف التسريب
- مراقبة علامات التحسس وهي الحكة الحمي الصداع التشنج



Subcutaneous S C تحت الجلد

التعريف : هو عبارة عن حقن سائل يعطي في الانسجة تحت الشحمية

الهدف :

- الادوية التي لا تعطي عن طريق الفم
- ادوية التخثر مثل الهبارين
- ادوية السكر - الأنسولين - ادوية بعض اللقاحات - الهرمونات

الموقع :

تحت الجلد اعلي الذراع - البطن من جوانب السرة-
الظهر اعلي الفخذ - يعطي بزاوية ٤٥ - يتحمل من
الدواء من ١ س الى ١/٢ س فقط
الاحتياطات : تحديد المنطقة بدقة - سحب النيدل لتأكد
من عدم وجود دم - حقن الدواء بالطف



في الجلد I.D Intra Dermal

التعريف : هو عبارة عن سائب يعطي في الجلد

الهدف :

يعطي فيه بعض اللقاحات مثل b.c.g

فحص السلين tb test - تجربة الحساسية - بعض الهرمونات

-- الموقع : في مقدمة الذراع - تحت الكتف - حسب امر الطبيب

-- الاحتياطات : عدم التطهير قبل وبعد - شد المنطقة - عدم فرك الندبة

وضع دائرة حول الندبة تحديد الوقت من ١٠ - ١٥ دقيقة

الاحتياطات العامة لا عطاء الحقن :

- التأكد من اسم الدواء الصحيح

- التأكد من تاريخ صلاحيته

- التأكد من طريقة الاعطاء

- تحديد الموقع بدقة

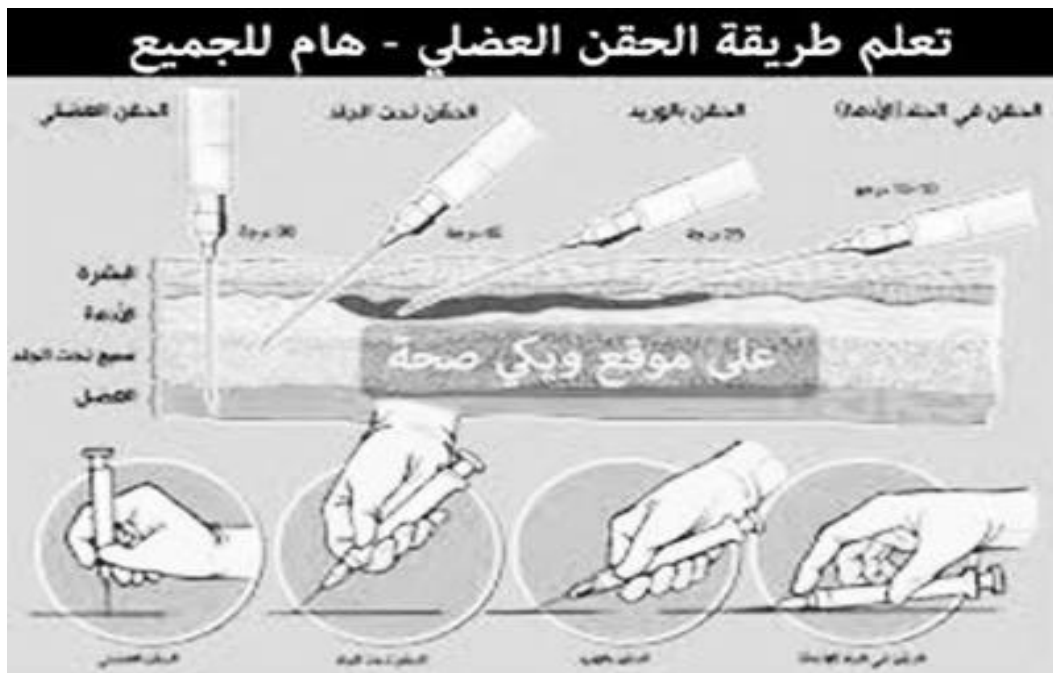
غسل اليدين قبل وبعد الاعطاء

- المحافظة علي العقيم

الحذر من حدوث أي مضاعفة تحدثها الحقن -

- التخلص من الادوات المستخدمة بطريقة صحيحة كالحرق

تنسيق د/جلال الكريزي



اعطاء الادوية

التعليمات العامة :

- ١—التحقق من الدواء المعطاة
- ٢—معرفة نوع الدواء والتأثيرات الجانبية التي قد تحدث
- ٣—الانتباه في كيفية تحضير الدواء والتحقق من اسم الدواء واسم المريض الرباعي ورقم السرير
- ٤—التأكد من المريض قد تناول الدواء
- ٥—حمل الدواء في اناء مخصص
- ٦—التأكد من الكمية المقررة حسب الوقت والطريقة
- ٧-- ملاحظة المريض بعد استخدام الدواء
- ٨—التأكد من المحاليل الوريدية خاص تا المضاف اليها ادوية
- ٩-- متابعة العلامات الحيوية



تنسيق د/جلال الكريزي



حفرة الإبهام



خلف اليد



بين الأصابع



فرك راحة اليد



غسل وتجفيف



الرسغ



الأظافر



ظهر الأصابع

جدول يبين قاعدة اعطاء الحقن :

الحقن	الرمز	المكان	الكمية المحددة	الاحتياطات
العضل	I.M	المربع الأعلى الوحيشي	1-5CC	التطهير قبل وبعد زاوية ٩٠ التأكد من خلو السرنية من الدم تعميق النيدل تلائم النيدل مع حجم الآلية
الوريد	I.V	في أي وريد	1-1000CC وأكثر	التأكد ظهور الدم التطهير قبل وبعد ملائمة الكنيولات مع الوريد الابتعاد من أماكن التمفصل في حالة المحالييل الوريدية
تحت الجلد	SIC	في الكتف	1CC-1/2	التطهير قبل وبعد الزاوية ٤٥ التأكد من خلو السرنية من الدم
الجلد نفسه	I.D	في أي مكان من الأطراف	5,0	عدم التطهير قبل وبعد ملاحظة ظهور الندبة الانتباه من تعمق النيدل

تنسيق د/جلال الكريزي

الرمز	الكلمة	الرمز	الكلمة	الرمز	الكلمة
p.s	بعد الطعام	P.R.N	وقت اللزوم	q.1h	كل ساعة
H.P	هيموجلوبين	SPP	تحاميل	H.S	عند النوم
O.S	الفم	SUP	تحت اللسان	q.2h	كل ساعتين
With	بدون	A.M	الصباح	Cap	كبسولة
Oat	ازالة	B.M	المساء	Tap	حبوب
P.O	بالفم	B.P	الضغط	Syrp	شراب
R.L	رينجر	P	النبض	B.I.D	مرتان باليوم
KUIK	بسرعة	T TUMP	الحرارة	T.I.D	ثلاث مرات باليوم
SLO	ببطء	Resp	التنفس	Q.I.D	اربع مرات باليوم
O2	اكسجين	drops	قطر	a.s	قبل النوم
N.P.O	الامتناع عن الطعام	dressing	مجارحة	With	مع
MLRARYSMEAR	ملاريا	Urine	بول	Egsam	فحص
SHOGER	السكر	stool	براز	Blood	الدم
Cellmate	تسمم الحمل	mopiese	يمشي	Ceardix	الملف

الحقن الشرجية Enema

الهدف منها :

- ١- تفريغ الامعاء ٢- قبل اجراء العملية
- ٣- الامساك المزمن ٤- قبل دخول المنظار الامعاء
- ٥- عملية البواسير ٦- عند الولادة المتعسرة
- الاحتياطات : ١- يجب وضع المريض بالوضعية الصحيحة
- ٢- تنظيف المنطقة قبل ادخال القسطرة
- ٣- وضع مادة زالقة كالجلي مثلا
- ٤- ادخالها بحركة دائرية
- ٥- رفع الحقنة عن مستوي الجسم
- ٦- التأكد من تفريغ الحقنة كاملا
- ٧- جعل المريض ينتظر ويتمشي ان كان قادرا
- ٨- التأكد من خروج الحقنة
- ٩- في حالة عدم خروجها ابلاغ الطبيب فورا
- ١٠- هناك نوعان من الحقن : ١- حقن دوائية جاهزة من الصيدلة
- ٢- حقن يعدها الممرض حسب قرار الطبيب اما من الزيت والماء
- واما من الماء والصبون ويجب ان يكون دافئا

القسطر

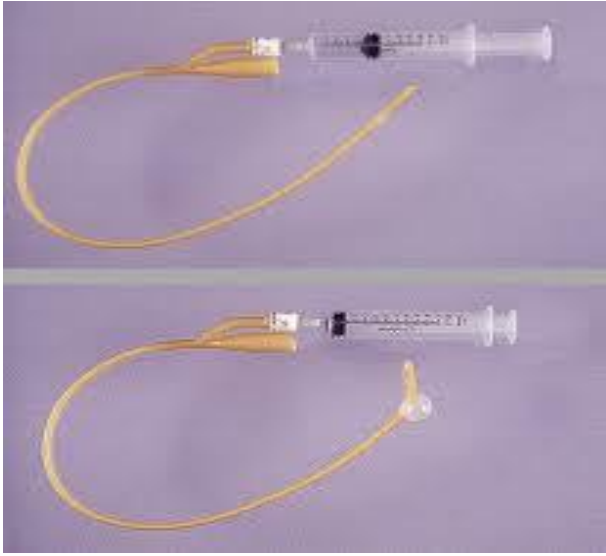
القسطرة البولية : Folly Cattier

الهدف منها :

- ١- قبل اجراء العملية ٢- عند احتباس البول
- ٣- مشاكل في الجهاز البولي ٤- الشلل
- ٥- الغيبوبة ٦- كسور العمود الفقري او الحوض
- ٧- الحروق من الدرجة الثالثة وخاصة اذا كانت بنسبة ٥٠٪
- ٨- عند الولادة المتعسرة او اخذ فحص للمزرعة

الاحتياطات اللازمة :-

- ١- التأكد من منطقة البول خاصة البنت لتجنب المضاعفة المستقبلية
- المحافظة علي التعقيم وضع مادة عازله علي القسطرة
- ٢- التأكد من خروج البول وظهوره في القسطرة
- ٣- حساب كمية السوائل الداخلة والخارجة



تنسيق د/جلال الكريزي

القسطرة المعدية

الهدف منها

- ١- غسيل المعدة في حالة التسممات
- ٢- التغذية في حالة :
 - ١- الاطفال الخدج وناقصي الوزن
 - ٢- الغيبوبة
 - ٣- الحروق خاصة الوجه
 - ٤- عمليات الفم
- الاحتياطات : ١- قياس مستوي المعدة ووضع علامة علي القسطرة وتكون كالتالي من الانف ← الي الاذن ← الي فتحة الفؤاد
- ١- وضع جلي مخدر موضعي كا للدوكائين
- ٢- خفض الرأس وادخالها من احد فتحات الانف
- ٣- نطلب من المريض ان يبلع باستمرار
- ٤- سرعة ادخالها
- ٥- نضع السماعة علي المعدة ووضع سرنج في الفتحة الخارجية ونفخ كمية قليلة من الهواء لسماع توضع القسطرة في المعدة
- ٦- في الخدج ادخالها من الفم
- الغسيل كالتالي : ادخال ٥٠ س س محلول ملح اشفط المحلول ورمية وهكذا حتي نتأكد ان المحلول يخرج نضيف اضافة حليب مع فحم طبي مطحون وادخاله للمعدة

تنسيق د/جلال الكريزي



٩٠)



تنسيق د/جلال الكريزي

خياطه الجروح

• أنواع الخياطات:

- تجرى الخياطات لتسريع الالتئام و ذلك بتقريب حواف الجرح الى بعضها و تعطي نتائج حسنة و تؤدي لندبة غير معيبة(في الجروح النظيفة) أما في الجروح التي يحدث فيها ضياع مادي كبير فلا تخاط و انما تضمد وهي مفتوحة أو يستعمل الطعوم أو الشرائح.
- أما الجروح المنتنة فالالتئام بالمقصد الثاني أو الثالث أفضل لها.

• أنواع الخيوط:

- عادة تصنف حسب قدرة الجسم على امتصاصها الى:
 - ١-خيوط قابلة للامتصاص
 - ٢-خيوط غير قابلة للامتصاص
- وبشكل عام وليس دائما الخيوط القابلة للامتصاص تحدث تفاعل التهابي أكبر في الجسم .
- والخيوط تقسم الى خيوط وحيدة الجذيلة و خيوط مجدولة والمجدولة تحدث تفاعل التهابي أكبر و قد تحمل الجراثيم بين الجذائل.

الخيوط القابلة للامتصاص :-

- ١- خيوط القصابة catgut: أول الخيوط القابلة للامتصاص المستعملة، مجدولة تحدث تفاعل التهابي كبير، تصنع من أمعاء الخرفان و الأبقار، تمتص عن طريق البلعمة خلال أسبوعان، تستعمل في خياطة تحت الجلد و ربط الأوعية الصغيرة و المتوسطة.
- ٢- خيوط القصابة المعاملة بالكروم chromic catgut: وهي خيوط قابلة للامتصاص مجدولة تمت معاملتها بالكروم ليصبح الامتصاص أبطأ يتم الامتصاص خلال ٢٠-٢٥ يوم عن طريق البلعمة، تستعمل في اغلاق الأغشية المخاطية و ربط الأوعية الدموية.
- أول خيط polyglycolic acid - بولي غليكوليك أسيد (الديكسون) صناعي قابل للامتصاص مجدول، يحتفظ ب ٦٠ % من قوته في اليوم السابع، يمتص باللحمة بواسطة انزيمات خلال ٩٠ - ١٢٠ يوم
- خيط صناعي مجدول يشبه polyglactin ٤- بوليغلكتين (الفيكريل) الديكسون يحتفظ ب ٦٠ % من قوته في اليوم ١٤، يمتص باللحمة خلال ٦٠ - ٩٠ يوم
- (خيط صناعي وحيد الجديلة يحتفظ PDS ٥- البوليديوكسانون) ب ٧٤ % من قوته في اليوم ١٤، يمتص باللحمة خلال ١٨٠ - ٢١٠ يوم

الخيوط غير القابلة للامتصاص :

- ١-الخيوط العضوية: مثل
- الحرير مازال يستعمل بشكل شائع، رخيص الثمن، يحدث تفاعل التهابي شديد ،مجدول.
- القطن والكتان لم تعد تستعمل الا قليلا
- ٢-الخيوط الصناعية:
- النايلون: هناك نوعان مجدول و وحيد الجديلة ،الوحيد الجديلة يحتفظ ب٣/٢ قوته حتى بعد ١١ عاما.
- البرولين وحيد الجديلة

Stables:

- مصنوعة من نوعية عالية من الفولاذ،تستعمل لأغلاق الجروح التي تحت شد عالي مثل الأطراف والجذع والفروة،سهلة الاستعمال قد تنقص الزمن اللازم لأغلاق الجروح بحدود ٧٠-٨٠%،لاستعمل في اغلاق الجلد الرقيق و فوق النتوءات العظمية،
- الفوائد:الزمن،انقاص خطر تموت حواف الخياطة و الانتان
- السلبيات:التكلفة أعلىالتقريب أقل دقة لحواف الجلد
- الجروح ، عادة يتم اجراء تحسين وظائف الكلية بالغسيل أو الرحض

تنسيق د/جلال الكريزي

الأدوية:

الأدوية الكيميائية المستعملة في الأورام تؤخر شفاء الجروح

: Tables

- هناك العديد من الأشرطة strips المكونة من الورق أو البلاستيك والمغطاة بمادة لاصقة تستعمل لأغلاق الجروح مثل micro porous tape وهي اما تستعمل لوحدها أو كداعم للقطب.
- الفوائد: سهولة الاستعمال، والرفع، لا حاجة لزيارة الطبيب لرفعها، مريحة للمريض
- السلبيات: لا تقرب دقيق للحواف، استعمالها محدود عند وجود أشعار

المواد اللاصقة: Tissue adhesives:

- Octylcyanoacrylate استعمال سوائل لاصقة مثل (تستعمل عند المرضى غير المتعاونين والجروح Dermabond) البسيطة خاصة الأطفال، وتحت الجبس، لا حاجة للطبيب بعدها، تترك ندبة جيدة
- السلبيات: التكلفة أعلى، الحاجة لتقريب كامل قبل وضع اللاصق

أنواع الخياطات

Interrupted Stitch

الخيطة ذات القطب المتفرقة البسيطة :

- الخيطة ذات القطب المتفرقة (البسيطة): أكثر الطرق استعمالاً، تترك ندبة مقبولة، المسافة بين القطبة و الأخرى ١ سم، العضة ٢/١ سم، يجب عدم الشد فقط تقريب لأن الشد يخرّب وقد يقطع الأنسجة و قد يقلل التروية الدموية ويزيد خطر الوذمة والتموت.

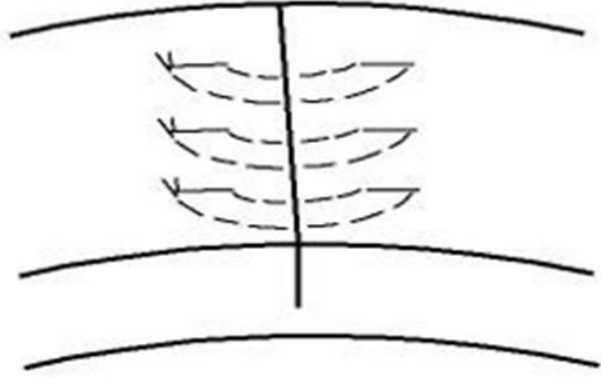
Running, or Continuous Stitch

الخيطة المستمرة (الشلالية)

- يستعمل خيط واحد بشكل شلال، خيطة البريتوان، فروة الرأس لأنها تترك ندبة مخفية، سرعة بالخيطة و الرفع و تستوعب وذمة الجرح أكثر ، احتمال عدم تقريب الحواف للجرح أكبر من البسيطة

Mattress Suture :

- قطبة مضاعفة أما عموديا أو أفقيا، تخترق كل طرف من الجرح مرتان، فائدتها قوة اغلاق الجرح



Mattress interrupted

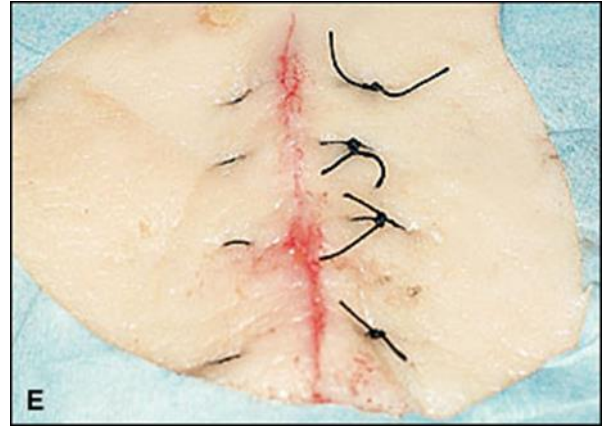
المستمرة مع Continuous Locking, or Blanket Stitch قفل(البطانية) :

قطب مستمرة مع قفل تستعمل بشكل أساسي في خياطة الجلد

الخياطة المبطنة(الداعمة) :

- تستعمل عندما يكون هناك خوف من اندحاق الجرح، و يستعمل قطعة من شاش أو بلاستيك ويمرر الخيط عبرها لسند الجرح فنحصل على خياطة متينة دون ضغط أو تمزق بالجرح





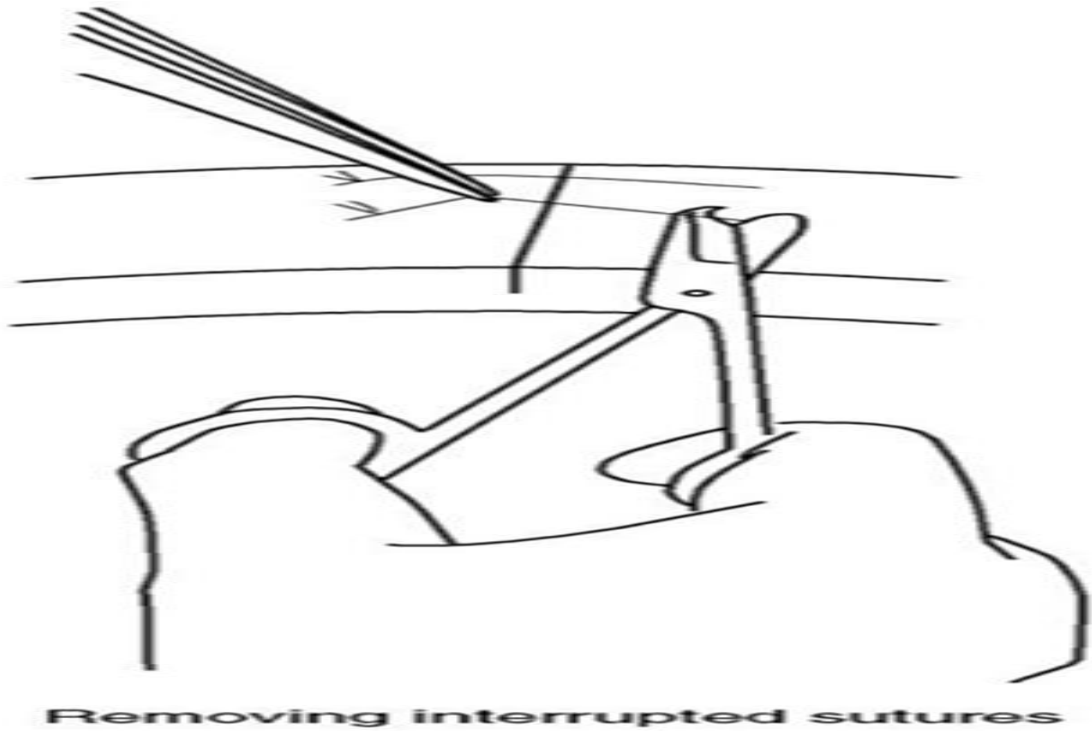
PATRIS

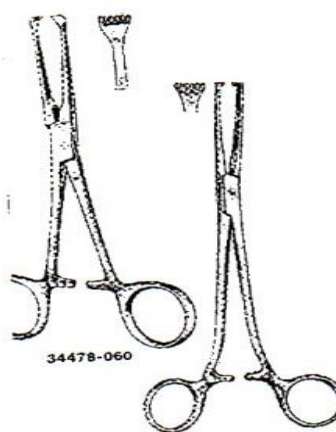
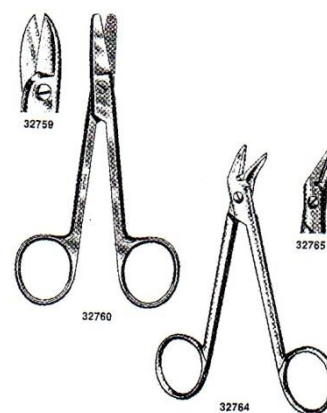
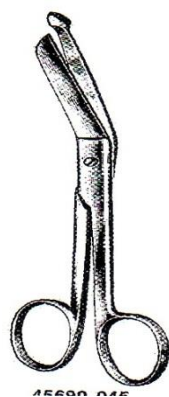
The horizontal mattress suture:



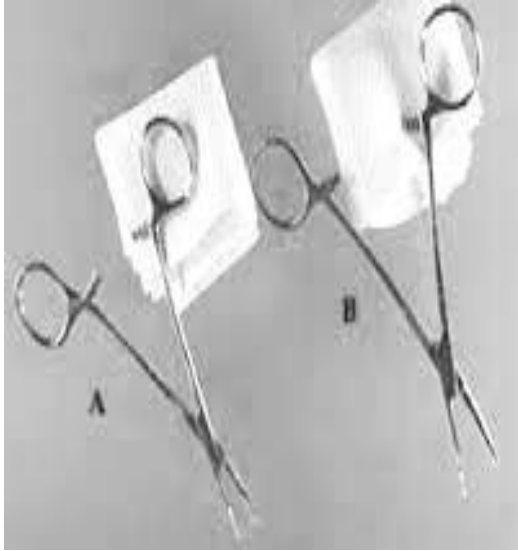
رفع الخيوط :

- عادة ترفع الخيوط بعد ٦-٨ أيام وفي جروح الوجه بعد ٣-٤ أيام
لكون التروية الدموية جيدة فالالتئام أسرع، أما جروح البطن
فترفع القطب بعد ٧-١٠ أيام و جروح الطرف السفلي و الظهر
بعد ١٤ يوم.
- و دائما عند رفع القطبة يتم امساك طرف الخيط و سحبه من
الداخل للخارج و ليس العكس خوفا من حدوث انتان
- ولا يجوز ترك الخيوط الغير القابلة للامتصاص لفترة طويلة لأنها
تساعد على حدوث انتان أو تقرحات أو ندب

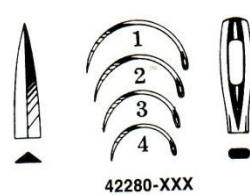
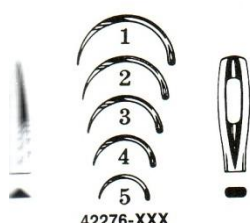




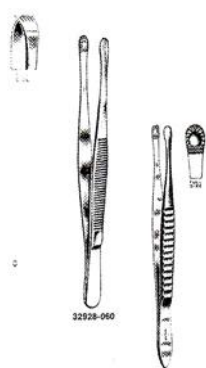
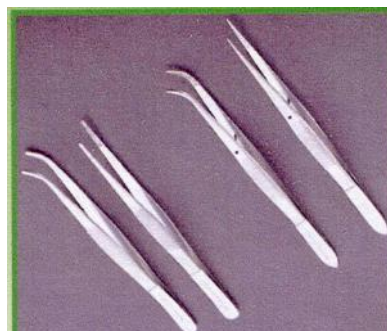
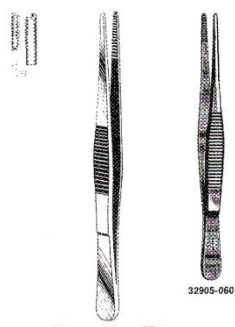
تنسيق د/جلال الكريزي



تنسيق د/جلال الكريزي



Needle holder



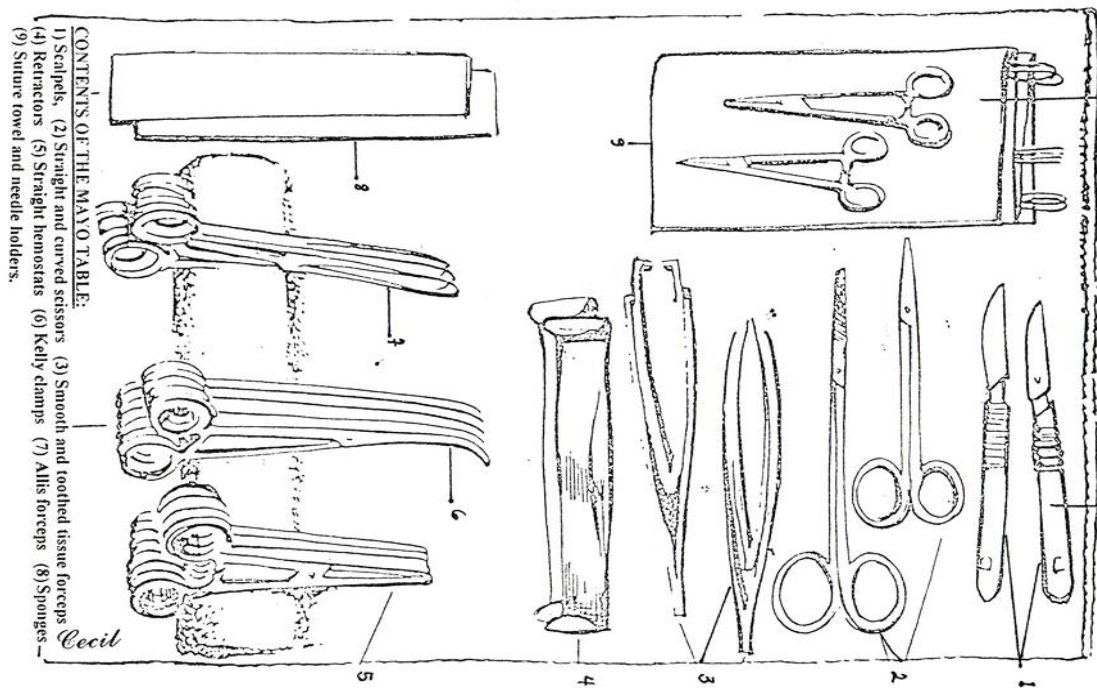


Illustration 6: The "ink pen" hold for a scalpel.

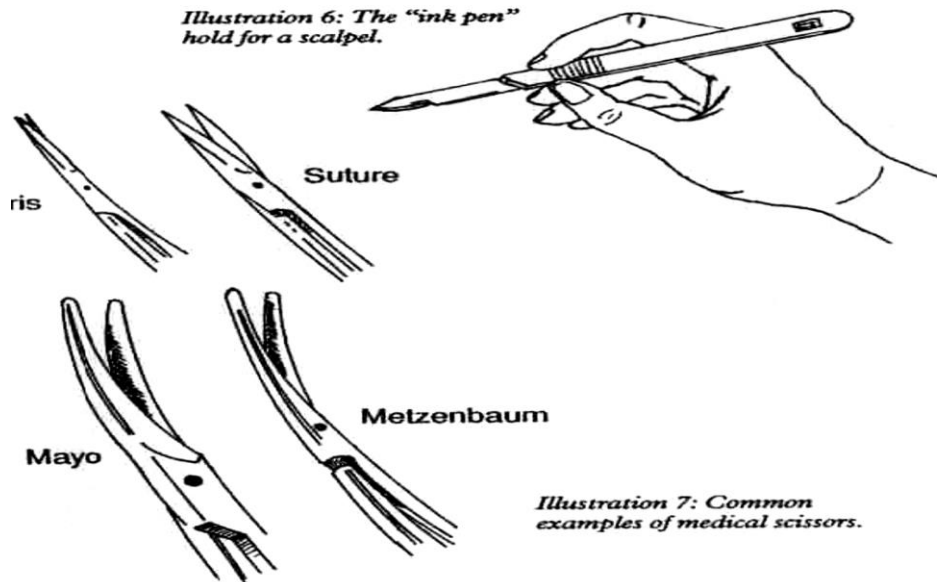


Illustration 7: Common examples of medical scissors.

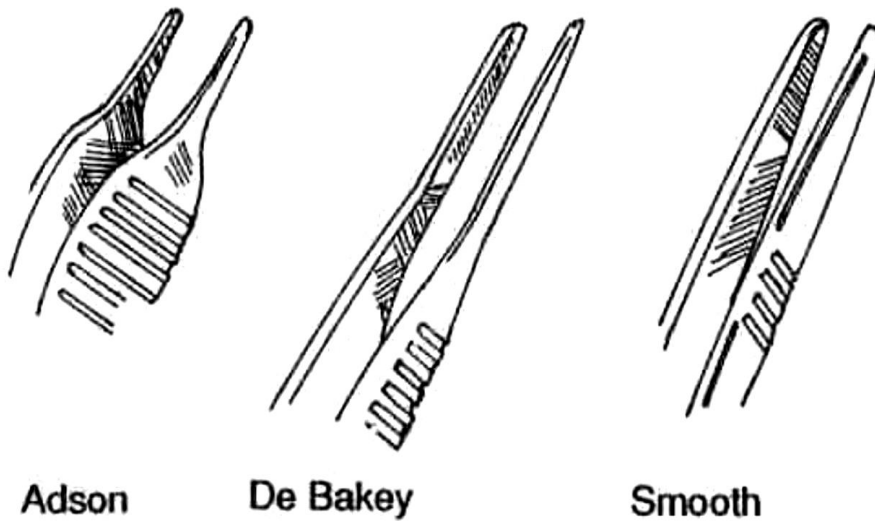
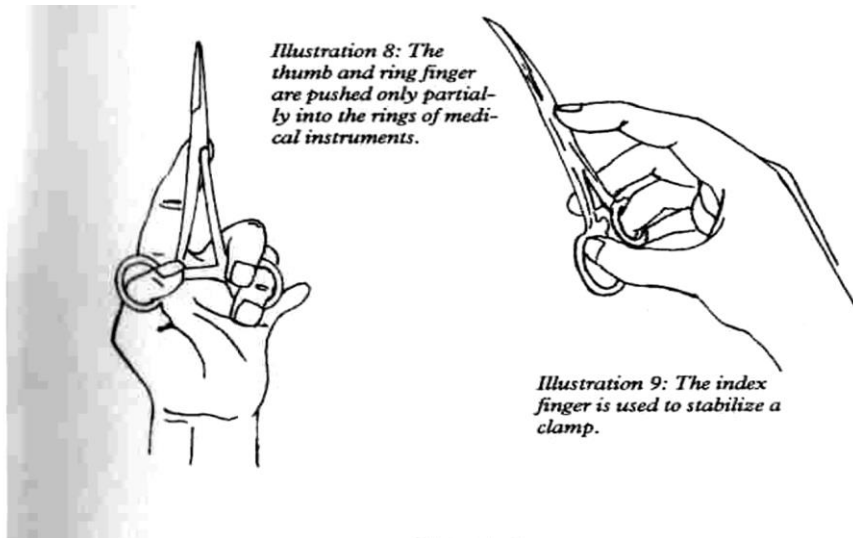


Illustration 10: Commonly used forceps.

ration.



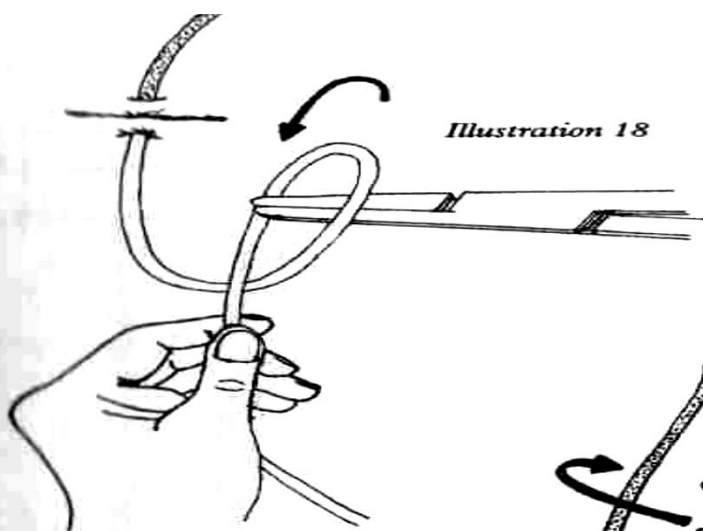


Illustration 18

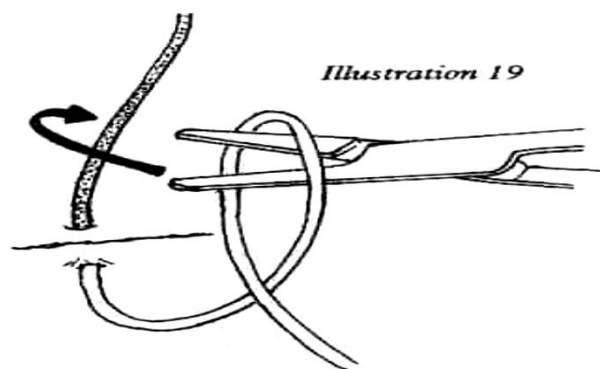


Illustration 19

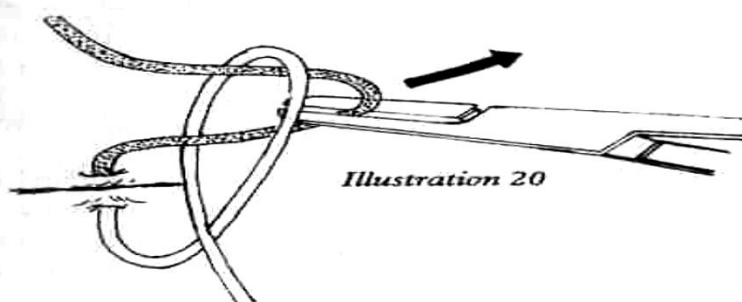


Illustration 20

